

Это детальное исследование мочеточника — трубки, по которой моча движется из почки в мочевой пузырь — проводится под анестезией. Хирург комбинирует несколько методов, чтобы точно определить расположение и протяжённость сужения и выбрать оптимальный вид операции.

Об этом исследовании

Сужение (стриктура) мочеточника трудно оценить снаружи, поэтому хирург осматривает его напрямую под анестезией. В зависимости от ситуации может использоваться **любое сочетание** следующих методов:

- **Диагностическая уретероскопия** — тонкая гибкая камера вводится в мочеточник для осмотра изнутри.
- **Ретроградная пиелография** — контрастное вещество вводится *снизу вверх* через мочевой пузырь, затем выполняется рентгенография для визуализации канала.
- **Антеградная пиелография** — при наличии дренажной трубки почки контраст подаётся *сверху вниз* через сужение.
- **Цистоскопия / цистограмма** — осмотр мочевого пузыря и его рентгенография.

Цель — получить точную «карту»: расположение, длину и степень сужения. Во время того же визита может быть установлен или заменён **стент** либо дренажная трубка почки.

Это безопасно?

Да. Это стандартная, малорискованная процедура. Большинство пациентов отмечают лишь кратковременную кровь в моче, лёгкое жжение или тянущую боль в боку. Редкие осложнения — инфекция мочевыводящих путей или кратковременное раздражение мочеточника; повреждение мочеточника случается крайне редко. Анестезия, как правило, очень безопасна.

ТЕРМИНЫ

Мочеточник

Трубка, по которой моча движется из почки в мочевой пузырь.

Стриктура

Рубцовое сужение, замедляющее или блокирующее отток мочи.

Уретероскопия

Осмотр мочеточника изнутри с помощью тонкой гибкой камеры.

Ретроградная пиелография

Рентген мочеточника и почки после введения контраста снизу вверх из мочевого пузыря.

Антеградная пиелография

Рентген после введения контраста сверху вниз через дренажную трубку почки.

Нефростомическая трубка

Трубка, дренирующая почку через спину; через неё можно вводить контраст.

Контрастное вещество

Жидкость, дающая белое изображение на рентгене для визуализации канала.

Стент

Мягкая внутренняя трубка, удерживающая мочеточник открытым; может быть установлена или заменена.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Во время исследования вы спите под анестезией и ничего не чувствуете. После можно ожидать лёгкого жжения при мочеиспускании, тянущей боли в боку или розовой мочи в течение одного-двух дней. Процедура короткая, и, как правило, вы уходите домой в тот же день.

Как подготовиться

- Исследование проводится под **анестезией** — соблюдайте все хирургические предписания (голодание, отмена препаратов, в том числе антикоагулянтов).
- Анализ мочи** проверяет наличие инфекции — активная инфекция должна быть пролечена заранее.
- Не удаляйте имеющуюся **дренажную трубку почки или стент** и **организуйте сопровождение домой**.

Сообщите врачу заранее, если вы:

- Когда-либо имели реакцию на **рентгеноконтрастное вещество или йод**
- Принимаете **антикоагулянты** или имеете признаки инфекции мочевыводящих путей

Что происходит во время исследования

- 1 Вы засыпаете под анестезией; вводятся антибиотики.
- 2 Цистоскоп вводится в мочевой пузырь. Контраст подаётся вверх по мочеточнику под контролем рентгена и/или камера проводится в мочеточник для осмотра изнутри.
- 3 При наличии дренажной трубки почки контраст может быть введён сверху, чтобы показать сужение с обеих сторон.
- 4 Данные картируются; при необходимости устанавливается или заменяется стент или дренажная трубка.

После исследования

- Вы выходите из анестезии и обычно **уходите домой в тот же день** в сопровождении.
- Возможны **лёгкое жжение, боль в боку или розоватая моча** в течение одного-двух дней. Пейте больше воды.
- Если установлен стент, лёгкие позывы или дискомфорт при мочеиспускании — норма.
- Хирург изучит полученные данные и обсудит с вами следующие шаги лечения.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб
- Сильная или нарастающая боль в боку или животе
- Обильное кровотечение или сгустки крови в моче
- Затруднённое мочеиспускание или стойкая тошнота/рвота

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Исследование картирует сужение мочеточника под анестезией с помощью камеры и контраста снизу и/или сверху, чтобы хирург мог выбрать оптимальный вид операции.
2. Поскольку используется анестезия, соблюдайте режим голодания и предписания по препаратам, вылечите инфекцию заранее, не удаляйте дренажную трубку или стент и организуйте сопровождение домой.
3. Большинство пациентов уходят домой в тот же день. Лёгкое жжение, боль в боку или розоватая моча на день-два — норма: пейте больше воды и обращайтесь к врачу при температуре, сильной боли или обильном кровотечении.